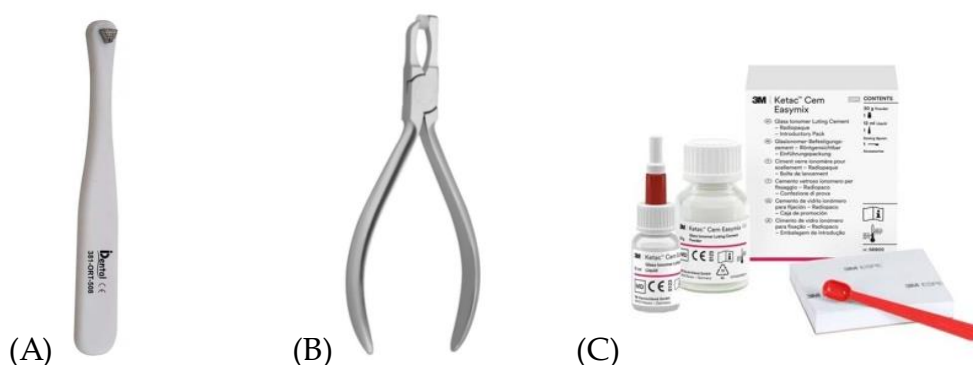


PROTOCOLO DE MANTENEDORES DE ESPACIO

Clínica Universitaria de Odontología

Material necesario

- Alginato con dosificadores, taza, espátula y cubeta.
- Pieza de mano y fresas.
- Mordedor (A).
- Quitabandas (B).
- Cemento de ionómero de vidrio (KetacCem) (C), loseta para mezclar y espátula.
- Algodones y aspirador.
- Papel articular (8 μ m).
- Turbina y fresas.



Tras determinar la necesidad de colocar un mantenedor de espacio tras la pérdida prematura de un diente de leche y escoger cual es el más adecuado para el caso concreto, el protocolo de elaboración y colocación se divide en tres citas:

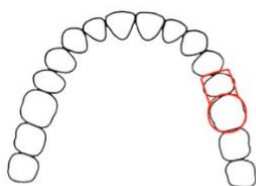
PROTOCOLO

1ª Cita – Medida + Orden al laboratorio

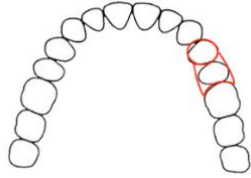
1. Toma de impresión de la arcada correspondiente con alginato, teniendo algunas consideraciones al referirnos al caso particular de pacientes odontopediátricos:
 - Técnica de la impresión: Elegir la cubeta más adecuada para la arcada dental del niño. En caso de necesitar tomar impresión de las dos arcadas, empezar siempre por la inferior. Usar las proporciones de agua y polvo indicadas por la casa comercial. Siempre colocar el material en la cubeta de atrás hacia adelante, no sobrecargar la cubeta, colocar al niño en posición ligeramente inclinada hacia adelante e indicarle que respire por la nariz.
 - Técnica de distracción y explicación: Al inicio, explicarle al niño que vamos a utilizar una plastilina para hacer una foto de sus dientes. Durante la impresión juega con él, ejemplos:
 - Pídele que levante un pie, luego el otro, para que este distraído.
 - Cuenta con él hasta 10 mientras el alginato endurece, lo ve como un reto y lo mantiene ocupado.

Al final, es recomendable utilizar un refuerzo positivo inmediato. Felicitarlo y enseñarle la impresión como “la huella de sus dientes”.

2. Enviar al laboratorio la hoja con las instrucciones:
 - Solicitamos: Prueba de banda/s para el diente X (señalar el diente en el que queremos que vaya la banda).
 - Especificar el tipo de mantenedor que vamos a elaborar, lo mejor es adjuntar un dibujo como los que os muestro a continuación con el diseño del aparato para que las instrucciones sean claras:
 - Banda-ansa.



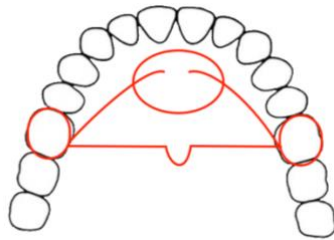
- Propioceptivo.



- Arco lingual con bandas a los 6's y omegas mesiales.



- Botón de Nance con barra palatina.



2ª Cita – Prueba de bandas

1. Colocar la banda confeccionada por el laboratorio en boca.
2. Revisar la adaptación y pasividad.
3. Comprobar que la banda no interfiera con la oclusión ni irrite tejidos.
4. Para retirarla, nos ayudamos del quitabandas.
5. Si la banda está bien, devolverla al laboratorio para terminar el mantenedor. Si hay alguna interferencia, podemos ajustarla con una fresa y la pieza de mano.
6. Si el tamaño de la banda no es el adecuado, devolverla al laboratorio indicando el problema y solicitando una nueva prueba de bandas.

3ª Cita – Cementado del mantenedor.

Probar el mantenedor de espacio y comprobar que esté adaptado y pasivo. Siempre que sea posible por el diseño, asegurarlo con un hilo dental para evitar accidentes. Si el mantenedor está bien, procedemos a cementarlo de la siguiente manera:

1. Limpieza del diente pilar con un cepillo de profilaxis.
2. Colocar aislamiento relativo con rollos de algodón y aspirador. Podemos ayudarnos también de un OptraGate o un abre bocas.
3. Secar la superficie del diente.
4. Mezclar el cemento de ionómero de vidrio en la proporción adecuada (1 cucharada de polvo y 2 gotas de líquido) durante 30 segundos.
5. Coloca el cemento dentro de la banda, cubriendo sobre todo la zona interna de las paredes.
6. Adapta la banda sobre el diente con presión digital o utilizando el mordedor de bandas.
7. Retirar excesos de cemento con una sonda o una torunda de algodón.
8. Verificar ajuste y la oclusión con papel articular, si es necesario retocar con fresa y turbina y dar indicaciones de higiene y cuidado.

Una vez que el mantenedor de espacio ha cumplido su función (cuando el diente para el que se estaba preservando el espacio ya ha erupcionado) es necesario retirarlo:

1. Colocar el quitabandas apoyando la parte activa sobre el margen gingival de la banda y el fulcro sobre la cara oclusal del molar.
2. Realizar movimientos suaves de palanca en todo el perímetro del diente hasta desalojar la banda de manera controlada, evitando traumatismo en tejidos blandos o esmalte.
3. Retirar todo el aparato en bloque.
4. Eliminar restos de ionómero de vidrio (KetacCem) con explorador, cureta o fresa de acabado.
5. Realizar profilaxis del diente pilar con pasta profiláctica.
6. Verificar que no haya daño en esmalte ni en tejidos blandos.
7. Realizar controles de erupción periódico.

